片側性舞踏病の鑑別

脳梗塞・高血糖・薬剤性を見逃さない

医知創造ラボ ～脳神経内科医がAIで紡ぐ最新医療情報～

片側性舞踏病とは何か

定義

・ 片側の四肢・顔面に出る不規則な不随意運動

・ 素早く、非律動的で、流れるように移動

・ 近位筋優位で激しい型 = ヘミバリスム

• hemichorea ↔ hemiballismus は連続スペクトラム

臨床的ポイント

「病名」ではなく「症候」

→ 背景に原因疾患がある

片側に限局 → 対側の脳に
構造病変・代謝異常を疑う

急性〜亜急性発症では
後天性・可逆的な原因を優先

片側性舞踏病の主な原因

脳血管障害

最多 68%
脳梗塞・脳出血

高血糖関連

糖尿病性線条体症
高齢女性に多い

薬剤性

D2遮断薬、制吐薬
レボドパなど

自己免疫性

抗リン脂質抗体症候群
SLE、Sydenham

変性・遺伝性

ハンチントン病
高齢初発は稀

成人発症散発性舞踏病の68%が脳血管障害（*Bovenzi 2021*）

見逃し注意①：脳血管障害

古典的な責任病巣

- 対側 視床下核
- 被殻・尾状核
- 視床

新しい知見

基底核が保たれた皮質梗塞でも
hemichoreaが起こる！

頭頂葉・島皮質・前頭葉
（Carbayo 2020）

⚠ 「基底核に異常がない＝血管性を否定」にはならない

DWI再読影：基底核だけでなく頭頂葉・島皮質・centrum semiovaleまで確認

突然発症なら急性脳卒中として対応

見逃し注意②：高血糖性舞踏病

糖尿病性線条体症の特徴

- 高齢女性に多い
- 88.1%がhemichorea/hemiballismus
- 平均血糖 414 mg/dL
- 平均HbA1c 13.1%
- 22%で糖尿病の初発所見

画像所見

CT：対側線条体の高吸収

MRI：T1高信号（対側線条体）

CT/MRI不一致 ≒ 1/6

MRI正常例 5.2%あり

⚠ 糖尿病の既往がなくても22%が舞踏病で糖尿病と判明 → 必ず血糖・HbA1cを確認

画像が非典型でも高血糖性舞踏病は除外しきれない（Chua 2020, Hoffmeister 2024）

💊 🛡️ 見逃し注意③：薬剤性・自己免疫性

確認すべき薬剤

- 抗精神病薬（遅発性ジスキネジア）
- メトクロプラミド・ドンペリドン
- レボドパ・ドパミンアゴニスト
- 抗てんかん薬（フェニトイン等）
- 抗うつ薬
- 認知症治療薬の変更
- 最近の中止薬も含める

自己免疫性を疑う検査

- 抗核抗体（ANA）
- 抗カルジオリピン抗体
- 抗β2GPI抗体
- ループスアンチコアグラント

疑うヒント：

血栓症既往、livedo、
自己免疫疾患既往

鑑別の進め方 — 3ステップ

Step 1
可逆的原因を外す

- 血糖・HbA1c
- 電解質（Ca, Mg）
- 腎・肝機能
- 甲状腺機能
- 薬歴の総点検
- 頭部MRI（DWI）
- MRA

→

Step 2
血管性を詰める

- 脳梗塞リスク評価
- 心房細動検索
- 頸動脈エコー
- 心エコー
- ラクナ・白質病変確認

→

Step 3
免疫・腫瘍随伴

- ANA・aPL系
- 悪性腫瘍検索
- 自己抗体パネル
- 髄液検査

本当に舞踏病か？ — 他の不随意運動との鑑別

不随意運動	特徴	舞踏病との違い
ジストニア	同じ姿勢・方向に捻れる	舞踏病は不規則・流動的
ミオクローヌス	一瞬のピクつき	舞踏病はやや持続的で移動
アカシジア	内的焦燥感で動く	舞踏病は無意識に起こる
てんかん性	反復的・常同性が強い	舞踏病は非常同的
Pseudoathetosis	深部感覚障害に伴う	閉眼で増悪するのが特徴

💡 **判断に迷うときは動画記録が有用。睡眠で消えるか、歩行で悪化するかもチェック**

MRI・CTの落とし穴

血管性

- DWI：対側基底核（被殻・尾状核）
- 皮質梗塞のみで発症する例あり
- 慢性虚血変化に新鮮梗塞を埋もれさせない

高血糖性

- CT：線条体高吸収
- MRI：T1高信号（対側線条体）
- 治療後に画像も改善する

⚠ 画像の落とし穴

CT/MRI不一致

≒ 1/6

Chua 2020

症状と画像の時間的ずれ

≒ 10%

Chua 2020

MRI正常例

5.2%

Hoffmeister 2024

治療の考え方

原則：原因治療が先

- 脳血管障害 → 脳卒中として対応
- 高血糖性 → 厳格な血糖是正（インスリン・補液）
- 薬剤性 → 原因薬の中止・変更
- 自己免疫性 → 免疫抑制療法

対症療法

ハロペリドール
0.375〜0.75 mg/日

クロナゼパム
0.5〜1 mg/日

(Shiraiwa 2020)

⚠ 高齢者での注意点

- 傾眠・転倒リスク
- 嚥下低下・誤嚥
- 薬剤性パーキンソニズム
- QT延長
- 認知機能悪化

予後 — 可逆的原因が多い

82%

自然軽快 or 軽微な後遺症

Bovenzi 2021

原因別の注意点

- 高血糖性：血糖管理で多くが改善
- ただし再発率 ≒ 28%（Chua 2020）
- 血管性：二次予防が長期予後を左右
- 薬剤性：遅発性ジスキネジアは不可逆的な場合も

💡 **迅速な原因検索が予後を左右する — 「原因不明」で終わらせず可逆的原因を執拗に探す**

まとめ — Take Home Message

1. 片側性舞踏病は「病名」ではなく「症候」
→ 必ず原因疾患を探す

2. 成人発症の68%が脳血管障害
→ 画像検査を最優先に

3. 高血糖性舞踏病を必ず除外
→ 糖尿病の既往がなくてもHbA1cを確認

4. 画像の落とし穴に注意
→ 皮質梗塞、MRI偽陰性、CT/MRI不一致

5. 82%が改善する可逆的病態
→ 迅速な原因検索が予後を決める

参考文献

1. Bovenzi R, et al. Neurol Sci. 2021;42(12):5187-5196.

2. Cincotta M, Walker RH. Tremor Other Hyperkinet Mov. 2022;12:3.

3. Carbayo Á, et al. Cerebrovasc Dis. 2020;49(5):498-505.

4. Chua CB, et al. Sci Rep. 2020;10(1):1594.

5. Hoffmeister MC, et al. J Endocrinol Invest. 2024;47(1):21-34.

6. Chen Y, et al. Front Neurol. 2022;13:956470.

7. Shiraiwa N, et al. J Neurol Sci. 2020;417:117033.

ご視聴ありがとうございました